INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA

PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA INTERCORRÊNCIAS

2026

Av. João Machado Nº 1234 . Centro
João Pessoa . Paraíba
CEP: 58013 522
T. 83 2107 9500
www.hsvp-iwgp.com.br
iwgp90@hotmail.com

CNPJ: 09124165000140

1. INTRODUÇÃO

O Plano de Contingência para Intercorrências Hospitalares estabelece diretrizes para o reconhecimento, a comunicação, o gerenciamento e a resposta a situações inesperadas que possam comprometer a segurança do paciente, dos profissionais, dos acompanhantes e o funcionamento dos serviços hospitalares.

O documento visa padronizar as ações das equipes multiprofissionais diante de situações críticas, minimizando danos, reduzindo o tempo de resposta e assegurando a continuidade da assistência.

O plano integra as ações institucionais de gerenciamento de riscos e deve estar articulado aos protocolos assistenciais, ao Plano de Segurança do Paciente (PSP), ao plano de emergência institucional e aos demais documentos aplicáveis.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Estabelecer um fluxo institucional de resposta às intercorrências hospitalares, garantindo atendimento oportuno, comunicação efetiva, redução de riscos e continuidade segura da assistência.

2.2 Objetivos específicos

- ✓ Padronizar as condutas iniciais diante de intercorrências.
- ✓ Definir responsabilidades das equipes assistenciais, lideranças e setores de apoio.
- ✓ Estabelecer critérios de acionamento das equipes de resposta.
- ✓ Reduzir a ocorrência de danos decorrentes de falhas assistenciais, operacionais e estruturais.
- ✓ Garantir a comunicação e o registro adequado das ocorrências.
- ✓ Estabelecer mecanismos de notificação, investigação e implementação de melhorias.
- ✓ Assegurar a disponibilidade de recursos humanos, materiais e equipamentos essenciais.

3. ABRANGÊNCIA

Este plano aplica-se a todas as unidades e aos profissionais do hospital, incluindo:

- ✓ Unidades de internação.
- ✓ Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
- ✓ Pronto atendimento, quando existente.
- ✓ Centro cirúrgico e recuperação pós-anestésica.
- ✓ Unidades de diagnóstico e apoio terapêutico.
- ✓ Farmácia hospitalar e demais áreas de armazenamento de medicamentos.
- ✓ Laboratório e serviço de imagem.
- ✓ Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIRAS).
- ✓ Engenharia clínica e manutenção.
- ✓ Higienização, rouparia, nutrição e demais serviços de apoio.
- ✓ Recepção, segurança patrimonial e setores administrativos.

4. DEFINIÇÕES

Intercorrência: situação inesperada que exige avaliação ou intervenção para prevenir ou minimizar consequências negativas.

Contingência: conjunto de medidas previamente estabelecidas para responder a situações que possam comprometer a assistência ou o funcionamento hospitalar.

Evento adverso: incidente relacionado à assistência à saúde que resulta em dano ao paciente.

Resposta rápida: acionamento de profissionais capacitados para avaliação e intervenção diante de deterioração clínica ou outra emergência prevista em protocolo institucional.

Continuidade assistencial: manutenção dos cuidados essenciais, mesmo diante de limitações operacionais ou interrupções de recursos.

5. CLASSIFICAÇÃO DAS INTERCORRÊNCIAS

A classificação abaixo orienta a prioridade de resposta. A gravidade deve ser definida conforme a avaliação da situação e os protocolos específicos.

Classificação	Conduta geral
Baixa complexidade	Intervenção imediata pela equipe do setor, com comunicação à liderança quando indicada.
Moderada	Acionamento da liderança assistencial e dos profissionais responsáveis, com monitoramento e registro.
Grave ou crítica	Acionamento imediato da equipe de emergência ou resposta rápida, quando aplicável, e comunicação à liderança.
Institucional ou coletiva	Ativação do plano de emergência institucional, com coordenação pela equipe designada pela direção.

A classificação não deve atrasar o atendimento. Na presença de risco iminente à vida, deve-se acionar imediatamente o fluxo de emergência pertinente.

6. PRINCIPAIS INTERCORRÊNCIAS E MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA

6.1 Intercorrências clínicas

Exemplos: deterioração clínica, alteração aguda do nível de consciência, insuficiência respiratória, convulsão, choque, reação alérgica grave e parada cardiorrespiratória.

Medidas de contingência:

- ✓ Reconhecer imediatamente os sinais de gravidade.
- ✓ Acionar o médico responsável e/ou a equipe de resposta rápida, conforme protocolo institucional.
- ✓ Iniciar as medidas de suporte previstas no protocolo específico, dentro das competências profissionais.
- ✓ Disponibilizar equipamentos e materiais necessários à emergência.
- ✓ Monitorar o paciente e registrar a evolução clínica e as intervenções realizadas.
- ✓ Providenciar transferência para unidade de maior complexidade, quando indicada.
- ✓ Comunicar a liderança assistencial e registrar a ocorrência conforme os critérios institucionais.

Responsáveis: equipe assistencial do setor, médico responsável, equipe de resposta rápida e liderança de enfermagem.

6.2 Parada cardiorrespiratória

Av. João Machado Nº 1234 . Centro
João Pessoa . Paraíba
CEP: 58013 522
T. 83 2107 9500
www.hsvp-iwgp.com.br
iwgp90@hotmail.com

CNPJ: 09124165000140

- ✓ Reconhecer a situação e acionar imediatamente o código de emergência institucional.
- ✓ Iniciar reanimação cardiopulmonar e utilizar o desfibrilador conforme o protocolo vigente e a capacitação da equipe.
- ✓ Garantir o atendimento por profissionais habilitados.
- ✓ Registrar horários, intervenções, medicamentos administrados e desfecho.
- ✓ Realizar comunicação com a liderança e os setores pertinentes.
- ✓ Encaminhar o caso para análise institucional quando indicado.

Responsáveis: equipe assistencial, equipe de emergência e médico responsável.

6.3 Erros de medicação e reações adversas

Exemplos: medicamento incorreto, dose inadequada, via errada, omissão, administração em paciente errado ou reação adversa grave.

Medidas de contingência:

- ✓ Interromper a administração, quando ainda estiver em curso e for clinicamente apropriado.
- ✓ Avaliar imediatamente o paciente e comunicar o médico responsável.
- ✓ Implementar as medidas clínicas indicadas para a situação.
- ✓ Identificar o medicamento, a dose, a via e o horário envolvidos.
- ✓ Preservar as informações necessárias à investigação, sem atrasar o atendimento.
- ✓ Comunicar a liderança e a farmácia hospitalar, conforme o caso.
- ✓ Registrar os cuidados prestados e notificar o incidente no sistema institucional.
- ✓ Realizar análise das causas e implementar medidas preventivas, quando aplicável.

Responsáveis: profissional envolvido, médico, enfermagem, farmácia e NSP.

6.4 Queda de paciente

- ✓ Avaliar o estado clínico do paciente imediatamente.
- ✓ Evitar movimentação inadequada quando houver suspeita de lesão ou contraindicação clínica.
- ✓ Acionar avaliação médica conforme a gravidade e o protocolo institucional.
- ✓ Implementar medidas diagnósticas e terapêuticas indicadas.
- ✓ Comunicar a liderança e registrar as circunstâncias da ocorrência.

- ✓ Notificar o incidente e reavaliar o risco de queda.
- ✓ Implementar medidas corretivas relacionadas ao ambiente, à supervisão e ao plano de cuidados.

Responsáveis: equipe assistencial, liderança de enfermagem e NSP.

6.5 Falta de medicamentos, materiais ou insumos essenciais

- ✓ Identificar imediatamente o item indisponível e o impacto assistencial.
- ✓ Comunicar a farmácia ou o almoxarifado e a liderança responsável.
- ✓ Consultar estoques de segurança e unidades de apoio autorizadas.
- ✓ Providenciar reposição prioritária para pacientes em risco.
- ✓ Utilizar alternativas terapêuticas somente mediante avaliação e autorização dos profissionais competentes.
- ✓ Registrar a indisponibilidade, o período de duração e as medidas adotadas.
- ✓ Avaliar a necessidade de reforço do estoque mínimo e revisão do processo de reposição.

Responsáveis: farmácia, almoxarifado, enfermagem, equipe médica e gestão de suprimentos.

6.6 Falha de energia elétrica, gases medicinais ou abastecimento de água

Medidas de contingência:

- ✓ Acionar imediatamente a manutenção e a equipe responsável pela infraestrutura.
- ✓ Identificar os pacientes e os setores potencialmente afetados.
- ✓ Acionar os sistemas de emergência disponíveis, conforme a natureza da falha.
- ✓ Garantir suporte prioritário aos pacientes dependentes de equipamentos ou gases medicinais.
- ✓ Disponibilizar fontes alternativas autorizadas e seguras.
- ✓ Avaliar a necessidade de transferência interna ou externa de pacientes.
- ✓ Comunicar a direção e registrar o período de interrupção, os riscos identificados e as providências adotadas.
- ✓ Manter a assistência em condições seguras até a normalização do serviço.

Responsáveis: manutenção, engenharia clínica, lideranças assistenciais, direção e segurança patrimonial.

6.7 Falhas nos sistemas de informação e prontuário eletrônico

- ✓ Comunicar imediatamente a tecnologia da informação e a liderança do setor.
- ✓ Ativar o procedimento institucional de contingência para registros em papel.
- ✓ Utilizar formulários padronizados e garantir identificação correta do paciente.
- ✓ Manter o registro de prescrições, administração de medicamentos, evolução e demais informações essenciais.
- ✓ Garantir comunicação segura entre os profissionais.
- ✓ Após a normalização, inserir ou reconciliar os registros conforme o procedimento institucional, preservando os dados originais, a autoria e a rastreabilidade.

Responsáveis: tecnologia da informação, equipes assistenciais, gestão documental e lideranças.

6.8 Suspeita de surto infeccioso ou aumento de infecções relacionadas à assistência

- ✓ Identificar e comunicar imediatamente os casos suspeitos ao SCIH/CCIH.
- ✓ Implementar as precauções indicadas conforme a avaliação epidemiológica.
- ✓ Reforçar higiene das mãos e medidas de prevenção e controle de infecções.
- ✓ Avaliar a necessidade de investigação epidemiológica e coleta de amostras.
- ✓ Comunicar as lideranças e a direção.
- ✓ Adotar medidas adicionais conforme avaliação do SCIH/CCIH e autoridades sanitárias, quando aplicável.
- ✓ Monitorar os casos e registrar as medidas implementadas.

Responsáveis: SCIH/CCIH, equipe assistencial, laboratório, NSP e direção.

6.9 Incêndio, fumaça, ameaça estrutural ou necessidade de evacuação

- ✓ Acionar imediatamente o sistema institucional de emergência.
- ✓ Comunicar a brigada de incêndio e os responsáveis pela segurança.
- ✓ Seguir o plano de emergência e abandono de área.
- ✓ Priorizar a proteção da vida e a retirada de pessoas em risco, conforme o plano específico.
- ✓ Realizar movimentação de pacientes de forma organizada, considerando sua condição clínica e dependência de equipamentos.

- ✓ Direcionar pacientes e profissionais para áreas seguras previamente definidas.
- ✓ Manter controle e identificação dos pacientes transferidos.
- ✓ Não retornar à área afetada sem liberação dos responsáveis competentes.

Responsáveis: brigada de incêndio, segurança patrimonial, lideranças assistenciais, manutenção e direção.

Responsáveis: equipe médica, enfermagem, gestão de leitos, regulação e transporte assistencial.

7. FLUXO GERAL DE RESPOSTA À INTERCORRÊNCIA

Etapa 1 — Identificação: qualquer profissional que identifique uma situação de risco deve comunicar imediatamente a equipe responsável.

Etapa 2 — Proteção imediata: adotar medidas para reduzir o risco, dentro das competências profissionais e dos protocolos aplicáveis.

Etapa 3 — Acionamento: chamar o profissional, a equipe de resposta ou o setor de apoio correspondente à ocorrência.

Etapa 4 — Contenção: impedir a continuidade da exposição ao risco e preservar a segurança das pessoas envolvidas.

Etapa 5 — Comunicação: informar a liderança assistencial e os responsáveis institucionais pertinentes.

Etapa 6 — Registro: documentar a ocorrência, os horários, as ações realizadas, os profissionais envolvidos e o desfecho.

Etapa 7 — Notificação: registrar o incidente no sistema institucional, conforme os critérios estabelecidos.

Etapa 8 — Análise e melhoria: avaliar as causas, definir ações corretivas e preventivas e acompanhar sua efetividade.

8. RESPONSABILIDADES

8.1 Direção hospitalar

Garantir recursos para execução do plano.

Aprovar o documento e suas revisões.

Apoiar decisões que envolvam restrição de atividades, transferência de pacientes ou ativação de planos institucionais.

Acompanhar os resultados e as ações de melhoria.

8.2 Lideranças assistenciais

Organizar a resposta inicial do setor.

Garantir o acionamento das equipes necessárias.

Avaliar os riscos e comunicar a direção quando pertinente.

Verificar a disponibilidade de profissionais, equipamentos e insumos.

Assegurar os registros e a continuidade dos cuidados.

8.3 Equipes multiprofissionais

Reconhecer e comunicar intercorrências.

Executar as medidas previstas nos protocolos aplicáveis.

Registrar informações de maneira completa e fidedigna.

Participar das notificações, análises e capacitações.

8.4 Núcleo de Segurança do Paciente (NSP)

Apoiar o gerenciamento dos riscos assistenciais.

Monitorar incidentes e eventos adversos.

Promover a análise dos eventos prioritários.

Propor barreiras preventivas e ações corretivas.

Acompanhar indicadores e planos de ação.

Articular-se com os setores responsáveis e apoiar a capacitação institucional.

8.5 Setores de apoio

Atender às solicitações relacionadas à sua área.

Disponibilizar recursos e informações necessárias.

Comunicar falhas, riscos e limitações operacionais.

Registrar as intervenções técnicas e acompanhar a normalização dos serviços.

9. COMUNICAÇÃO E REGISTRO

Toda intercorrência deverá ser comunicada oportunamente aos responsáveis, considerando a gravidade, o risco e a necessidade de intervenção.

Avenida Walfredo Guedes Pereira, 1900 - Centro
João Pessoa - Paraíba
CEP: 58015-922
T. 83 2107 9500
www.hsvp-iwgp.com.br
iwgp90@hotmail.com

CNPJ: 09124165000140

O registro deve conter, conforme aplicável:

- ✓ Data e horário da ocorrência.
- ✓ Setor e local.
- ✓ Identificação do paciente, quando pertinente.
- ✓ Descrição objetiva dos fatos.
- ✓ Condição clínica ou operacional identificada.
- ✓ Profissionais e setores acionados.
- ✓ Medidas imediatas adotadas.
- ✓ Evolução e desfecho.
- ✓ Necessidade de transferência ou suporte adicional.
- ✓ Notificação institucional e encaminhamentos realizados.

A comunicação deve preservar a confidencialidade das informações e observar as normas institucionais de documentação e proteção de dados.

10. NOTIFICAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTES

As ocorrências relacionadas à assistência devem ser notificadas no sistema institucional (SIGQUALI), conforme os critérios estabelecidos pelo hospital.

O NSP, em conjunto com os setores envolvidos, deverá avaliar a necessidade de investigação, priorizando eventos com dano grave, eventos sentinela, recorrências e situações com potencial significativo de dano.

A análise poderá utilizar metodologias estruturadas, como Protocolo de Londres, análise de causa raiz, Diagrama de Ishikawa e os Cinco Porquês, conforme a complexidade do caso.

A investigação deverá identificar fatores contribuintes relacionados a processos, comunicação, equipamentos, ambiente, organização do trabalho e recursos disponíveis.

Quando aplicável, o hospital deverá realizar as notificações externas exigidas pela legislação e pelos fluxos sanitários vigentes.

11. CAPACITAÇÃO E SIMULAÇÃO

A instituição deverá promover capacitações periódicas sobre:

- ✓ Reconhecimento da deterioração clínica.
- ✓ Acionamento da resposta rápida e atendimento à parada cardiorrespiratória.

- ✓ Segurança na administração de medicamentos.
- ✓ Prevenção e conduta após quedas.
- ✓ Utilização segura de equipamentos.
- ✓ Comunicação efetiva e passagem de plantão.
- ✓ Contingência para falhas de infraestrutura e sistemas.
- ✓ Evacuação e resposta a emergências institucionais.

Recomenda-se realizar simulações práticas, registrar a participação das equipes e avaliar o desempenho, as dificuldades identificadas e as melhorias necessárias.

12. MONITORAMENTO E INDICADORES

O NSP e as lideranças responsáveis deverão acompanhar os indicadores pertinentes ao perfil institucional.

Indicador	Método de acompanhamento
Tempo de acionamento da equipe de resposta	Horário da identificação versus horário do acionamento
Tempo de resposta às intercorrências críticas	Horário do acionamento versus chegada da equipe, conforme protocolo
Percentual de incidentes com registro completo	Registros completos ÷ total de registros avaliados × 100
Percentual de ações corretivas concluídas	Ações concluídas ÷ ações previstas × 100
Adesão às capacitações	Profissionais capacitados ÷ público previsto × 100
Recorrência de falhas operacionais	Quantidade de falhas repetidas por período
Cumprimento das simulações previstas	Simulações realizadas ÷ simulações programadas × 100

As metas e a periodicidade de análise deverão ser definidas pela instituição, considerando a linha de base, os riscos prioritários e a capacidade operacional.

13. DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente plano deverá ser divulgado aos profissionais e integrado aos protocolos assistenciais e operacionais do hospital.

Cada setor deverá conhecer os fluxos de acionamento, as responsabilidades e os recursos disponíveis para resposta às intercorrências.

A implementação depende de validação institucional, definição dos contatos e códigos de emergência, disponibilidade de recursos, capacitação das equipes e aprovação formal pela direção.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 36, de 25 de julho de 2013.** Institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013.** Institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Plano Integrado para a Gestão Sanitária da Segurança do Paciente em Serviços de Saúde 2026–2030.** Brasília: Anvisa, 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolos de Segurança do Paciente.** Brasília: Ministério da Saúde.

As referências e os protocolos institucionais aplicáveis deverão ser conferidos e atualizados durante a aprovação formal deste documento.

Elaborado por:	Revisado por:	Reconhecido por:
Nayanne Ingrid Farias Mota Guerra Núcleo de Segurança do Paciente / Qualidade	Giulianna Carla Marçal Lourenço Coordenadora de enfermagem	Sonia da Silva Delgado Diretora Assistencial
	Data: 01/10/2026	Data: 01/10/2026